

INFILTRACIÓN DE CADERA

Nerea Sutil Reguera, Julio Tito Camino Acha, María Goreti Gutiérrez Raso, Angela Bezos Cuaresmara, Juan José González Fernández.

INTRODUCCIÓN

La patología más frecuente susceptible de infiltración es la bursitis trocantérea. Resulta difícil, distinguir el origen preciso de las estructuras que causa el dolor en la región trocantérea, denominamos genéricamente como bursitis trocantérea. En todo caso la técnica de infiltración es la misma. Sólo en caso de disponer de pruebas complementarias que aseguren que se trata de una bursitis, podremos hacer tal diagnóstico; en su defecto diagnosticaremos trocanteritis.

Indicaciones específicas

Susceptibles de infiltración en el servicio de urgencias, se deberá de pedir consentimiento informado escrito u oral, dejando reflejado en su historia clínica.

- Trocanteritis.
- Tendinitis abductores.
- Bursitis trocantérea.
- Tendinitis trocantérea (entensopatía de abductores de la cadera).
- Bursitis del ileopsoas.
- Coxartrosis.

Material

- **Antisépticos:** povidona yodada, alcohol 70°, guantes, gasas y paños estériles.
- **Agujas estériles.**
 - Subcutánea 25 G (naranja) de 0.5 x 16 mm.
 - Intravenosa 20 G (amarilla) de 0.9 x 25 mm.
 - Intramuscular 21 G (verde) de 0.8 x 40 mm.
 - Espinal 21 G (negra) de 0,9 x 90 mm.
- **Jeringas** estériles: 5 y 10 cc.
- **Fármacos.**
 - Mepivacaina HCl 2 % (Scandinibsa®) 1 vial= 2ml
 - Lidocaína 2% (Lidocaína®) 1 vial= 2ml
 - Betametasona acetato y fosfato sódico de betametasona (Celestone cronodose ®) 1 vial= 2ml =12mg
 - Parametasona acetato (Cortidene depot ®) 1 vial= 2ml = 40mg
 - Metilprednisolona acetato (Depo moderin®) 1 vial= 2ml = 80mg
 - Triamcinolona acetato (Trigon depot®) 1 vial= 1ml =40mg

Volumen de corticoide indicado: 0.25 - 1 ml en vainas tendinosas y tejidos blandos y 5 - 10 ml en articulaciones grandes. Dilución: 1:1 (1 ml de anestésico por cada ml de corticoide). Cargar primero el corticoide y luego el anestésico.

TROCANTERITIS

Posición del paciente	Decúbito lateral. Cadera flexionada 30-50° rodilla flexionada 60-90°
Aguja de infiltración	21G (verde).
Zona de punción	En el punto de mayor dolor a la palpación.
Dirección de la aguja	Perpendicular a la piel hasta el hueso y retiramos 3 mm.

BURSITIS Y TENDINITIS TROCANTÉREA

Posición del paciente	Decúbito lateral. Pierna superior en semiflexión de rodilla y cadera
Aguja de infiltración	21G o espiral (verde o negra).
Zona de punción	En el punto de mayor dolor a la palpación, sobre el trocánter mayor. Ligeramente superior y posterior (unos 2cm) del trocánter.
Dirección de la aguja	Perpendicular a la piel hasta llegar al hueso, retirar ligeramente e inyectar en abanico.

TENDINITIS ABDUCTORES

Posición del paciente	Decúbito supino. Con pequeña rotación interna, flexión y abducción.
Aguja de infiltración	25G (naranja).
Zona de punción	Próximo al punto de inserción de los tendones.
Dirección de la aguja	En el sentido de los tendones, hasta llegar a la zona subperióstica de inserción.

COXARTROSIS

Posición del paciente	Decúbito supino
Aguja de infiltración	21G o espinal (verde o negra)
Zona de punción	En la intersección de dos líneas: 1. Perpendicular nace a nivel de la E.I.A.S. 2. Horizontal nace a nivel del trocánter en sentido anterior. Se infiltrará a nivel del ángulo inferior interno.
Dirección de la aguja	Dirección a planos profundos hasta llegar a planos óseos.

Recomendaciones post infiltración.

- Retirar el apósito en aprox 8 - 12 horas y lavar la zona de punción.
- Reposo estricto de la articulación durante 24-48 horas. Es recomendable un reposo relativo de 2-3 semanas, en el caso de infiltración de tenovaginitis o bursitis.
- No practicar deporte al menos en 5 días.
- Recomendarle analgésicos durante las primeras horas.
- Si existe agravamiento después de las 48 horas, valorar infección.
- Valorar el efecto terapéutico en 10-15 días.

Posibles complicaciones.

- Infección local.
- Artritis aguda por depósito de microcristales de corticoides. Cede en 48 horas.
- Hemartros o hematomas.
- Sincope vasovagal.
- Reacción pseudonitroide. Cede espontáneamente.
- Atrofia cutánea y/o despigmentación.
- Rotura tendinosa.
- Lesión del cartílago, vasos, tendones o nervios.
- Reacción alérgica o toxicidad por anestésicos locales.
- Artropatía corticoidea.
- Poco frecuente: descompensación glucémica, excitación o depresión de SNC, elevación de la tensión arterial, necrosis aséptica de la superficie articular, calcificaciones en las zonas de inyección, sangrado uterino anormal, pancreatitis y dispepsia.

BIBLIOGRAFÍA

- Vidal Fuentes J. Técnicas de Infiltración Articular y de Tejidos Blandos. Madrid: luxan 5; 2015.
- Heraso Aragon M. Bloqueos nerviosos e infiltraciones. Madri: Marban; 2014.